Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Uruguaiana

Rua General Hipólito, 3392 - Bairro: São João - CEP: 97502441 - Fone: (55) 3412-1410 - Balcão Virtual (55)99913-2599 - Email: fruruguaia2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5008858-90.2022.8.21.0037/RS

AUTOR: ANA IZABEL VARGAS AUSANI
ADVOGADO(A): EMERSON VARGAS FONTELLA (OAB RS083429)

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

ANA IZABEL VARGAS AUSANI ajuizou a presente ação em face do **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL,** ambos qualificados na inicial (evento 1, INIC1). Conforme relatado na decisão concessiva da tutela de urgência: "Relata a autora é portadora da "...patologia CID 50.9, com doença localmente avançada de aproximadamente 7 cm na mama esquerda e linfonodomegalias em axila esquerda, de alto risco, de subtipo triplo negativo...", conforme prescreve o especialista (Dr. Tiago Giordani Camícia - CREME/RS 35578). Refere que necessita receber o medicamento Keytruda (Pembrolizumabe) 200mg a cada 3 semanas, na forma do receituário médico. Menciona que, ao solicitar o medicamento perante a parte requerida, teve seu pedido NÃO AUTORIZADO, sob o argumento de que o medicamento não está previsto nas suas atuais recomendações técnicas, como se observa da 'Solicitação' que vai anexada, datada de 30.06.22, o que é inaceitável. Assim, considerando a gravidade da doença e o fato de não haver nenhum outro medicamento disponibilizado pela requerida que o substitua com igual benefício clínico, ganho de sobrevida e aumento da qualidade de vida, recomenda o especialista, com urgência, o uso da medicação, de modo a se evitar a progressão da doença com envolvimento de outros órgãos vitais, menor resposta ao tratamento quimioterápico e risco de óbito. Portanto, diante do cenário postado, considerando as razões acima e o fato de ser hipossuficiente, não lhe restou outra alternativa que não o ajuizamento da presente demanda, para que lhe seja alcançado o medicamento prescrito pelo médico especialista, consoante receituário. Postula a concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida forneça à autora, no prazo de 05 (cinco) dias, Keytruda (Pembrolizumabe) 100mg, 02 ampolas/ciclo, a cada 03 semanas, na forma indicada no receituário médico". Requereu, ainda, a total procedência da presente ação para, tornando definitiva a tutela de urgência, condenar a requerida a custear o medicamento postulado até que perdure a necessidade da autora, bem como a concessão da gratuidade.

Juntou documentos no Evento 1 e, ainda, após determinação de emenda (evento 3, DESPADEC1), nos Eventos 6 e 7 e neste corrigiu o valor da causa para R$ 402.304,08, com base no menor orçamento.

Deferiu-se o pedido de tutela de urgência, bem como determinou-se a inclusão do feito em pauta de conciliação perante o CEJUSC (evento 9, DESPADEC1).

A autora informou que a parte requerida não disponibilizou o medicamento à autora, descumprindo, portanto, a decisão lançada pelo juízo. Requereu bloqueio de valores (evento 22, PED LIMINAR_ANT TUTE1) e juntou documentos.

Determinou-se a juntada de três orçamentos (evento 26, DESPADEC1).

Em sessão de conciliação perante o CEJUSC, realizada em 09/08/2022, não houve possibilidade de entendimento (evento 29, TERMOAUD1).

IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL apresentou contestação (evento 30, CONT1). Inicialmente, que a ordem judicial de fornecimento do medicamento ora postulado foi devidamente cumprida pelo demandado. Sustentou que IPE SAÚDE é entidade à qual compete a prestação de serviços de saúde aos funcionários públicos estaduais e que não pode ser compelida ao fornecimento de medicamentos, de materiais, próteses ou procedimentos que não constam na tabela de Órteses, Próteses e Materiais Especiais – TOPME do IPE SAUDE ou no Protocolo Oncológico organizado pela autarquia e não possuam cobertura para sua utilização. Disse que não se trata de ação contra o Estado, sendo imprescindível que haja correspondência entre fonte de custeio e amplitude dos benefícios. Defendeu a ausência de cobertura para o tratamento pretendido e, caso admitida a pretensão,a ocorência de inequívoco benefício à parte demandante em detrimento dos demais segurados, em afronta ao princípio da isonomia.Sustentou que deferir-se o pleito implica abalo aos princípios da igualdade, da legalidade e da independência e harmonia dos poderes. Defendeu amparo na Lei Complementar Nº 15.145, de 5 de abril de 2018, que dispõe sobre o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul ? Sistema IPE Saúde, e altera a Lei Complementar n.º 12.066, de 29 de março de 2004, citando os artigos 1º e 4º, pelo que a cobertura do plano está adstrita às despesas decorrentes dos procedimentos e medicamentos previstos em tabelas próprias do Instituto, sendo ilegal a pretensão. Discorreu sobre a a sustentabilidade do Fundo de Assistência à Saúde FAS. Sustentou que as atuais Recomendações Técnicas em Oncologia do Instituto IPE Saúde tiveram sua última edição pela Instrução Normativa nº 02, de 27 de abril de 20213, e no referido documento, não foram previstas alternativas terapêuticas para o tratamento de neoplasia de mama, e que a inclusão de novos tratamentos na cobertura do IPE Saúde deve passar por crivo rigoroso de demonstração de benefícios clínicos relevantes. Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos (evento 30, PROCADM2 e evento 30, PROCADM2).

A autora se manifestou no sentido da desnecessidade de bloqueio uma vez que recebeu a medicação e deu início ao tratamento (evento 32, PET1), algo confirmado pela parte demandada no evento 34.

A parte autora, ainda, manifestou-se em réplica, citando ementas sobre o tema e reiterando pleito de procedência (evento 37, RÉPLICA1).

Intimadas acerca do interesse na produção de outras provas (evento 39), as partes manifestaram desinteresse (eventos 43 e 46).

O Ministério Público opinou pela procedência da ação (evento 52, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a parte autora requer a condenação do réu ao fornecimento do fármaco *Keytruda* (*Pembrolizumabe*), na quantidade de 200mg a cada 3 semanas, a fim de tratar a moléstia que lhe acomete: neoplasia de mama - CID 50.9.

A obrigação de fornecimento do tratamento de saúde ora perseguido pela parte autora decorre da Constituição Federal.

Verifica-se nos autos que a requerente é filiada ao IPÊ-Saúde (evento 6, OUT2), algo, inlcusive, incontroverso, e que está acometida de neoplasia de mama - CID 50.9, *com doença localmente avançada de aproximadamente 7 cm na mama esquerda e linfonodomegalias em axila esquerda, de alto risco, de subtipo triplo negativo* (evento 1, LAUDO6).

Com efeito, cumpre registrar que, em 06/04/2018, entrou em vigor a Lei Complementar n.° 15.145/2018 - que revogou a Lei Complementar n.º 12.134/2004 - dispondo sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde e excluindo da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, §1º). Veja-se:

> *Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.*
>
> *§ 1º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.*

Contudo, a ausência de previsão do medicamento no protocolo do plano de saúde não pode ser suficiente para excluir o direito da parte autora ao tratamento prescrito como sendo o mais adequado ao seu diagnóstico.

Outrossim, o entendimento jurisprudencial é no sentido da impossibilidade do plano de saúde eleger as espécies de tratamento fornecidos ao segurado:

> ***Ementa:*** *AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPE-SAÚDE. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO PREVISTO EM TABELAS PRÓPRIAS. LEI 9.656/98. RECUSA ILEGAL.* ***1. O plano de saúde, inclusive no regime de autogestão, não pode excluir de sua cobertura procedimento, medicamento ou material para tratamento de doença prevista no contrato. Jurisprudência do STJ. 2. Afigura-se ilegal a recusa do IPE-SAÚDE em custear procedimentos, exames e medicamentos indispensáveis ao tratamento à saúde do segurado, ainda que que não constem das suas tabelas. Precedentes deste Tribunal. Hipótese em que há, nos autos, prova da necessidade dos medicamentos requeridos.*** *Recurso provido.(Agravo de Instrumento, Nº 53862359320238217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 08-03-2024)*
>
> *Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRATAMENTO DE SAÚDE. CONSIDERAÇÕES. 1. DO DIREITO AO TRATAMENTO. A necessidade do tratamento de saúde está comprovada nos autos, bem como a filiação da parte autora perante o IPÊ-SAÚDE. Subsunção, in casu, dos arts. 5º, caput, 6º, caput, e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar/RS n. 15.145/2018. 2. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO. É de preservação dos direitos fundamentais que se trata, evitando-se o seu esvaziamento em decorrência de restrições descabidas, desnecessárias ou desproporcionais. 3. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREVALÊNCIA SOBRE OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS PELA AUTARQUIA ESTADUAL. O argumento de que o tratamento não pode ser concedido em razão de não constar nos atos normativos editados pelo IPÊ-SAÚDE não prevalece diante do princípio constitucional da legalidade, pois ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5º, inciso II, da CF/1988).* ***A lei estadual não exclui a responsabilidade do plano de saúde de custear tratamento oncológico ao segurado, que contribui mensalmente para receber a assistência quando precisar. Limitações abusivas não prevalecem diante das normas constitucionais que garantem o direito à vida.*** *4. DO BLOQUEIO DE VALORES. Tratamento de saúde com custo elevado. Bloqueio de valores na conta do IPÊ-SAÚDE. Necessidade de três orçamentos. Observância daquele de menor valor. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50013496620158210001, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 12-05-2023)*
>
> ***Ementa:*** *AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO IPÊ-SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEOPLASIA MALIGNA UTERINA (CARCINOMA DE ENDOMÉTRIO) EM ESTÁGIO AVANÇADO (CID10 C54). CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Hipótese em que a demandante é segurado do IPERGS e foi diagnosticada com neoplasia maligna uterina (carcinoma de endométrio) em estágio avançado (CID10 C54), necessitando de tratamento medicamentoso de natureza oncológica -PEMBROLIZUMAB (KEYTRUDA), na dose de 200 mg, mediante aplicação via intravenosa. 2. Descabe considerar legítima a negativa da Autarquia, já que, naquilo em que o Plano de Saúde oferece cobertura, entende-se que ela deve ser a mais ampla possível, lembrando que, de acordo com o art. 2º da Resolução nº 21/79 são cobertos pelo IPE-SAÚDE "os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento" e que o art. 4º da Lei Complementar nº 15.145/2018 prevê "cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos", não se podendo admitir que o tão-só fato de a medicação prescrita não estar contida em critérios técnicos do IPE-SAÚDE seja óbice à determinação de cobertura. A negativa no fornecimento de tratamento específico pelo plano de saúde, sob a justificativa de não fazer parte da cobertura, revela-se contrário ao próprio regulamento que disciplina a matéria. O direito à saúde está diretamente relacionado à ideia de mínimo existencial, que constitui o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, de forma que a ausência de previsão do tratamento específico no regulamento do IPERGS não é motivo suficiente para o indeferimento. A prova documental carreada nos autos demonstra a necessidade da medicação indicada pelo*

médico responsável, garantindo sobrevida ao demandante. 3. Nesse contexto, considerando que restam devidamente comprovadas a gravidade do quadro clínico e a necessidade do medicamento oncológico, bem assim a urgência de seu fornecimento, deve ser mantido o efeito suspensivo já concedido. Precedentes deste TJ/RS AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52567186920228217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 26-04-2023).

APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS ***PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA)*** *E AXITINIBE (INLYTA) PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. Apelo da parte autora: Hipótese dos autos em que o recurso da parte autora versa exclusivamente acerca da majoração dos honorários sucumbenciais. O procurador da parte autora não é beneficiário da gratuidade judiciária, não efetuou o preparo no ato da interposição da apelação (art. 99, §5º, do CPC), tampouco atendeu à determinação para proceder ao pagamento em dobro, na forma do art. 1007, §4º, do CPC/15. Nesse contexto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade, imperioso não conhecimento do recurso, porquanto deserto. Apelo da Autarquia: Fornecimento de medicamentos fora dos protocolos. A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento da autarquia previdenciária não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/08, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários.* ***Em que pese as disposições do parágrafo primeiro do artigo supramencionado, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado. Hipótese dos autos em que restou comprovado através de relatório médico especializado a necessidade e urgência do fornecimento dos medicamentos ora solicitados, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que determinou a condenação da Autarquia ao fornecimento do tratamento para doença que acomete a parte autora, independentemente se os fármacos constam ou não em seus protocolos ou listas.*** *APELO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 50090431620218210021, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 15-12-2022). Grifei.*

Aliado a isso, tem-se a Resolução nº **21/79** do IPÊ-Saúde, que regulamenta a assistência médico-hospitalar do IPERGS e prevê, em seu art. 2° que *o Plano de Assistência Médica destinado aos associados e seus dependentes cobrirá os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento,* inclusive em área oncológica, conforme se denota da previsão contida no art. 8° da mesma Resolução:

Artº 8º - Incluem-se no Plano de Assistência Médica, em consonância com as respectivas normas, as seguintes especialidades: Anestesiologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geral, Ginecologia, Hematologia e Hemoterapia, Imunologia (Alergia), Medicina Nuclear, Nefrologia, Obstetrícia, Oftalmologia, ***Oncologia****, Otorrinolaringologia, Patologia Clínica e Cirurgia, Pediatria, Plástica reparadora, Proctologia, Psiquiatria, Radiologia, Radioterapia, Reumatologia, Tisiopneomologia, Torácica, Traumatologia e Urologia. - grifei*

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SAÚDE. SEGURADA DO IPE-SAÚDE.TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DEVER DE FORNECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM. ***1. Considerando que a negativa administrativa ocorreu após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 15.145/2018, aplicável tal legislação ao caso em tela. 2. Embora o artigo 4º da Lei Complementar nº 15.145/18, que revogou a Lei nº 12.134/04, disponha que integram o plano de saúde atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos, exceto os tratamentos não previstos nas tabelas do próprio Instituto, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é cristalino quanto à impossibilidade do plano de saúde eleger as espécies de tratamento fornecidos ao segurado. Logo, descabe interpretação restritiva, pois a responsabilidade quanto ao fornecimento do tratamento indicado, a fim de possibilitar o tratamento ao paciente - segurado, está atrelada ao que dispõe o referido artigo 2° da Resolução nº 21/1979, ou seja, "os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento". A fundamentalidade do direito à saúde faz com que sua garantia seja a expressão de resguardo da própria vida – maior bem de todos –, do qual a generalidade dos demais direitos se há de extrair o sentido. A prova constante dos autos dá conta da indicação médica para tratamento oncológico vindicado, sob risco de morte da paciente, restando cogente a manutenção da condenação ao fornecimento do tratamento.*** *3. Por outro lado, diante da identidade axiológica da questão presente com o REsp 1.657.156-RJ, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 25/04/2018, referente ao Tema nº 106, em face da semelhança dos direitos em conflito, imperioso exigir-se, para medicamentos fora da lista dos fornecidos pelo IPE-SAÚDE, a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da (a) imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pela autarquia, e a (b) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Na hipótese contida nos autos, os laudos comprovam a imprescindibilidade tratamento. Outrossim, não há dúvida de que o medicamento está devidamente registrado junto à ANVISA. Ademais, é necessário considerar que o médico assistente é quem detém a capacidade/perícia de indicar o melhor medicamento, de acordo com a eficácia que apresenta, para fins de curar ou minimizar a enfermidade que acomete a paciente. Nesse contexto, não se há de admitir a negativa da autarquia. 4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o Código de Processo Civil de 2015 fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários. No entanto, as ações relacionadas a medicamentos devem ser tratadas como de valor inestimável, pois os bens almejados são a vida e a saúde, e não apenas o fornecimento em si e o respectivo valor do fármaco, inexistindo acréscimo patrimonial em favor da parte autora. Sendo assim, a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, para a hipótese contida nos autos, mostra-se plenamente adequada, não se havendo falar em proveito econômico para fins de justificar o arbitramento da verba com fulcro no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Posição deste órgão fracionário. Ademais, tanto antes do julgamento do Tema 1076 como depois, o entendimento do Tribunal da Cidadania vai na direção de que, nas causas envolvendo tratamento de saúde, admite-se o juízo de equidade, no que diz com os honorários, porquanto o proveito econômico em tal situação é, em regra, inestimável. Redução da verba honorária para patamar adotado por esta Câmara. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50016589320228210146, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 07-02-2024)*

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA (CID 10-C50.9). FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS ABEMACICLIB E FEMARA. NEGATIVA DE COBERTURA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. CONCESSÃO DA TUTELA EM SEDE RECURSAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Hipótese em que a demandante, segurada do IPERGS, foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA (CID10 C50.9), necessitando das medicações prescritas por seu médico assistente para controle da referida doença, sendo indeferida, na origem, a tutela de urgência para determinar o fornecimento do fármaco, cuja dispensação fora negada na via administrativa. ***2. Descabe a negativa da Autarquia, já que, naquilo em que o Plano de Saúde oferece cobertura (no caso, oncologia), entende-se que ela deve ser a mais ampla possível, lembrando que, de acordo com o art. 2º da Resolução nº 21/79 são cobertos pelo IPE-SAÚDE "os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento" e que o art. 4º da Lei Complementar nº 15.145/2018 prevê "cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos", não se podendo admitir que o tão-só fato de a medicação prescrita não estar contida em critérios técnicos do IPE-SAÚDE seja óbice à determinação de***

cobertura. *Precedentes deste TJ/RS. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 53171078320238217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 18-12-2023). Grifei.*

Ademais, o já citado laudo médico acostado aos autos, revela a evolução da patologia que acomete a parte autora e a necessidade de utilização do fármaco ***Keytruda*** **(*Pembrolizumabe*),** postulado, de acordo com o quadro de saúde por ela apresentado.

Portanto, resta evidenciado o direito da parte autora, enquanto beneficiária, de postular ao IPE-Saúde o fornecimento da medicação necessária ao tratamento, mesmo que o fármaco não integre seus protocolos ou listas, porquanto se trata de medicamento indispensável à manutenção da sua saúde e relacionado a patologia prevista no contrato.

Nesses termos, a procedência é medida impositiva.

No tocante ao arbitramento dos honorários, considerando que se trata de ação que envolve direito à saúde, matéria cuja natureza não é de grande complexidade, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.906.618/SP (**TEMA 1076**), firmou a seguinte tese:

> *i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.*
>
> *ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.*

Com efeito, no caso em apreço, considerando o alto valor atribuído à causa e sua baixa complexidade, desproporcional a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa, devendo esta ser feita de forma equitativa porquanto inestimável o proveito econômico da demanda, já que se trata de ação na qual o pleito é, em suma, o fornecimento de tratamento médico e a garantia do direito à vida e à saúde da parte autora.

No mesmo sentido:

> ***Ementa:*** *APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. CIRURGIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO À SAÚDE, EM GERAL. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. TEMA Nº 1.076 DO STJ. APLICABILIDADE DO ITEM "II" ALÍNEA "A". FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC/15. ENTENDIMENTO DO STJ. MAJORAÇÃO. - Em se tratando de ação em que se discute Direito à Saúde, em geral, aplica-se o disposto no item "ii" alínea "a" do Tema nº 1.076 do STJ, o qual determinação a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade quando o proveito econômico for inestimável. Entendimento do próprio STJ em julgados posteriores à publicação do Tema supracitado. - Valor nominal dos honorários advocatícios majorado para R$ 2.500,00 por adequação aos parâmetros utilizados por esta Corte e por esta Câmara, em situações idênticas. REMESSA NECESSÁRIA. APLICAÇÃO DA EXEGESE DO ART. 496, §3º, DO CPC/15. NÃO CONHECIMENTO. - Não cabe remessa necessária nas ações de saúde movidas contra os entes públicos em que o valor anual da medicação não alcança o número de salários mínimos indicado no art. 496, §3º, do CPC/15 c/c Ofício-Circular n.º 062/2015 – CGJ. - Caso dos autos em que o valor dado a causa foi R$ 305.382,93, enquanto o mínimo exigido à época da sentença era R$ 706.000,00. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 50213010620228210027, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 15-03-2024).*

Pelo exposto, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **ANA IZABEL VARGAS AUSANI** em face do **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL,** para tornar definitiva a liminar deferida e determinar ao requerido providencie o tratamento recomendado à autora com o fornecimento do medicamento *Keytruda* (*Pembrolizumabe*), na quantidade de 200mg a cada 3 semanas, sob pena de custeio do tratamento necessitado, mediante bloqueio de valores.

Isento IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL do pagamento da taxa única (art. 5°, inc. I da Lei nº 14.634/2014). Condeno-o ao pagamento integral das despesas processuais (arts. 14 e 16 da Lei nº 14.634/2014) exceto condução do Oficial de Justiça, se houver (Ofício Circular nº 03/2014- CGJ).

Por outro lado, conforme fundamentação supra, condeno o IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL ao pagamento dos honorários sucumbenciais na quantia de R$ 2.500,00 ao procurador da parte autora, ora fixada levando em conta os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2°e 8° do Código de Processo Civil. O valor deverá ser corrigido pelo IPCA-E a partir da presente decisão e até o trânsito em julgado, quando deverá sobre tanto incidir unicamente a taxa *selic.*

Publicação e registro eletrônicos. Agendada a intimação das partes pelo sistema.

Em caso de interposição de apelação, intime-se a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

Caso seja suscitado, pela parte recorrida, em preliminar de contrarrazões, inconformismo contra decisões proferidas na fase de conhecimento não submetidas a agravo de instrumento, intime-se o recorrente para, no prazo legal, manifestar-se a respeito delas, nos termos do art. 1.009, §2º, do CPC.

A seguir, ao Ministério Público.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Com retorno dos autos, intimem-se as partes e/ou transitada em julgado a presente decisão, cumpridas as determinações finais da sentença passíveis de cumprimento *ex officio* e, nada sendo requerido, recolhidas eventuais custas pendentes ou adotadas as providências para sua cobrança administrativa, **arquivem-se.**

Documento assinado eletronicamente por **KARINA DE OLIVEIRA LEONETTI PADILHA, Juíza de Direito**, em 22/3/2024, às 10:17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10056866362v14** e o código CRC **23ecdee8**.